# 프로락틴 상승 시 진료 프로토콜

프로락틴(Prolactin)은 모유 분비와 생리 주기에 관여하는 뇌하수체 호르몬입니다. 한 번 높게 나왔다고 바로 큰 병을 의미하지는 않아, 검사 조건과 흔한 원인을 차분히 확인합니다.

## 진료실에서 보는 4단계 흐름

| 단계 | 진료실에서 하는 일 |
|---|---|
| STEP 01<br>**증상·약 확인** | 월경 변화, 유즙 분비, 두통·시야 증상과 복용약을 먼저 확인합니다. |
| STEP 02<br>**안정 상태 재검** | 가능하면 오전, 도착 후 휴식한 상태에서 다시 측정해 일시 상승을 걸러냅니다. |
| STEP 03<br>**흔한 원인 배제** | 임신 가능성, 갑상선 기능, 신장·간 기능, 약물 영향을 함께 봅니다. |
| STEP 04<br>**지속 상승 평가** | 반복 상승이나 증상이 있으면 뇌하수체 MRI(자기공명영상), 내분비 의뢰를 검토합니다. |

## 재검 전 준비와 함께 확인할 원인



긴장·수면 부족·격한 운동·임신/수유처럼 일시 상승 요인을 먼저 확인합니다.

| 재검 조건 | 확인할 원인 |
|---|---|
| **오전 채혈**을 우선 권장합니다. | **임신 가능성** 또는 최근 수유 여부 |
| **도착 후 10~20분 안정**하고 채혈합니다. | **갑상선기능저하**, 신장·간 기능 이상 |
| 전날 과격한 운동, 음주, 밤샘은 피합니다. | 항정신병약, 항구토제, 일부 항우울제, 진통제 |
| 검사 전 식사·공복 조건은 진료실 안내에 맞춥니다. | 다낭성난소증후군(PCOS), 월경 불규칙 |
| 검사 당일 복용약·영양제를 접수 시 알려주세요. | 반복 상승 시 뇌하수체 병변 가능성 |

## 바로 알려야 할 증상과 가져오면 좋은 정보

**진료실에 바로 알려주세요**

**시야가 좁아짐** 또는 물체가 겹쳐 보임

**새롭고 심한 두통**, 구토가 동반되는 두통

임신·수유와 무관한 유즙 분비

무월경, 월경 주기 변화, 난임 상담 중인 경우

**진료 때 준비하면 좋습니다**

복용 중인 약 이름, 용량, 시작 시점

최근 3개월 생리 주기와 마지막 생리 시작일

임신 가능성, 수유 여부, 피임약·호르몬제 사용

최근 스트레스, 수면 부족, 운동, 이전 검사 결과

**오늘 기억할 점**

프로락틴 상승은 **재검으로 확인**하고, 약물·임신·갑상선·신장 기능처럼 흔한 원인을 먼저 살핍니다. 반복해서 높거나 증상이 동반되면 영상검사나 내분비 진료로 이어질 수 있습니다.

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — Endocrine Society Hyperprolactinemia CPG · Endotext Prolactinoma Management

*본 자료는 공통 설명용입니다. 실제 진단과 치료는 증상, 복용약, 임신 여부, 재검 결과를 함께 보고 결정합니다.*

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/hyperprolactinemia-protocol/